Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vfaz@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5043201-89.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ELIETE MOREIRA LIVOTTO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ELIETE MOREIRA LIVOTTO ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de "Câncer de endométrio metastático" (CID10 C54.9) e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Pembrolizumabe 200 mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Solicitada documentação complementar (evento 4, DESPADEC1), foi juntada (Evento 9).

Deferida a gratuidade da justiça (evento 11, DESPADEC1).

Requisitado parecer técnico ao DMJ, foi acostada nota técnica com conclusão favorável (evento 16, NOTATEC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 19, DESPADEC1).

O IPÊ-SAÚDE informou a autorização para o medicamento postulado (evento 25, OFIC1).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 31, CONT1).

A parte autora replicou (evento 37, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 42, DESPADEC1), o autor postulou pela produção de prova oral e pericial (evento 45, PET1), e o demandado nada requereu (evento 48, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 51, PROMOÇÃO1).

Foi indeferido o pedido de prova oral e pericial (evento 53, DESPADEC1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 19, DESPADEC1):

> *"(...) Segundo o laudo médico que acompanhou a inicial (evento 1, LAUDO6), a parte autora tem diagnóstico de câncer de endométrio metastático (CID C54.9), refratário a tratamento com Paclitaxel e Carboplatina, não candidata à cirurgia de resgate. Aduz que a autora possui indicação de usar pembrolizumabe associado à levantinib, segundo estudo que demonstrou redução do risco de progressão e risco de morte em pacientes que utilizaram referida combinação. Esclarece a médica que não existe outra medicação que diminua risco de progressão da doença e morte no cenário da parte autora e o não uso implica em risco de vida. Por último, explana que a autora deve iniciar as medicações com máxima brevidade.*
>
> *Ademais, a Nota Técnica emitida pelo DMJ apresentou conclusão favorável com o teor transcrito abaixo.*
>
> *"[...] Tecnologia: PEMBROLIZUMABE Conclusão Justificada: Favorável*

Conclusão: Após reanálise da documentação anexada, considerando subgrupo específico de tratamento do estudo Keynote 775, conclui-se que também há benefício com pembrolizumabe associado a lenvatinibe no subgrupo de portadores de adenocarcinoma de endométrio refratário a carboplatina+paclitaxel com estabilidade microssatelite, porém de menor magnitude que na estabilidade microssatelite. A toxicidade de lenvatinibe por via oral pode ser motivo de interrupção do tratamento, devendo ser prontamente comunicada pelo médico assistente da parte autora.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não [...]"

Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se a tratamento utilizando o medicamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, em que pese este juízo não desconheça que em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.° 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde, revogando a Lei Complementar n.º 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto, não é facultado ao plano escolher quais tratamento serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Assim, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada, e comprovada a necessidade que possui em receber o tratamento pleiteado, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela pretendida.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** e determino ao IPE-Saúde que, no prazo de 10 (dez) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Pembrolizumab 200 mg**, nos termos da prescrição e laudo médico, os quais deverão ser atualizados pela parte autora semestralmente.(...)"*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO6; evento 1, EXMMED7; evento 1, EXMMED8), que indica possuir a parte autora diagnóstico de "Câncer de endométrio metastático" (CID10 C54.9) e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Pembrolizumabe 200 mg**. Da mesma forma, comprovada a **urgência** do tratamento. Senão vejamos:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE ELIETE MOREIRA LIVOTTO É PORTADORA SINTOMÁTICA DA PATOLOGIA CÂNCER DE ENDOMÉTRIO METASTÁTICO, CID C54.9, REFRATÁRIO À TRATAMENTO COM PACLITAXEL E CARBOPLATINA. A PACIENTE POSSUI INDICAÇÃO DE USAR PEMBROLIZUMABE SEGUNDO DADOS DO ESTUDO DE FASE III KEYNOTE 775 QUE DEMONSTROU REDUÇÃO DO RISCO DE PROGRESSÃO EM 44% (HR=0,56; P < 0,0001) E RISCO DE MORTE EM 38% DAS PACIENTES (HR = 0,63; P < 0,0001).

NÃO EXISTE OUTRA MEDICAÇÃO QUE DIMINUA RISCO DE PROGRESSÃO DE DOENÇA E MORTE NESSE CENÁRIO E O NÃO USO IMPLICA EM RISCO DE VIDA.

A PACIENTE DEVE INICIAR AS MEDICAÇÕES COM MÁXIMA BREVIDADE.

REFERÊNCIA:

FICO À DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS

CORDIALMENTE,

DRA JANAINA BROLLO

CREMERS 39753

Ademais, sobreveio nota técnica com parecer favorável (evento 16, NOTATEC1):

Conclusão

Tecnologia: PEMBROLIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Após reanálise da documentação anexada, considerando subgrupo específico de tratamento do estudo Keynote 775, conclui-se que também há benefício com pembrolizumabe associado a lenvatinibe no subgrupo de portadores de adenocarcinoma de endométrio refratário a carboplatina+paclitaxel com estabilidade microssatelite, porém de menor magnitude que na estabilidade microssatelite.
A toxicidade de lenvatinibe por via oral pode ser motivo de interrupção do tratamento, devendo ser prontamente comunicada pelo médico assistente da parte autora.

Há evidências científicas? Sim

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por ELIETE MOREIRA LIVOTTO em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Pembrolizumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo(a) médico(a) assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 21/11/2023, às 15:38:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10049490958v4** e o código CRC **39777c59**.